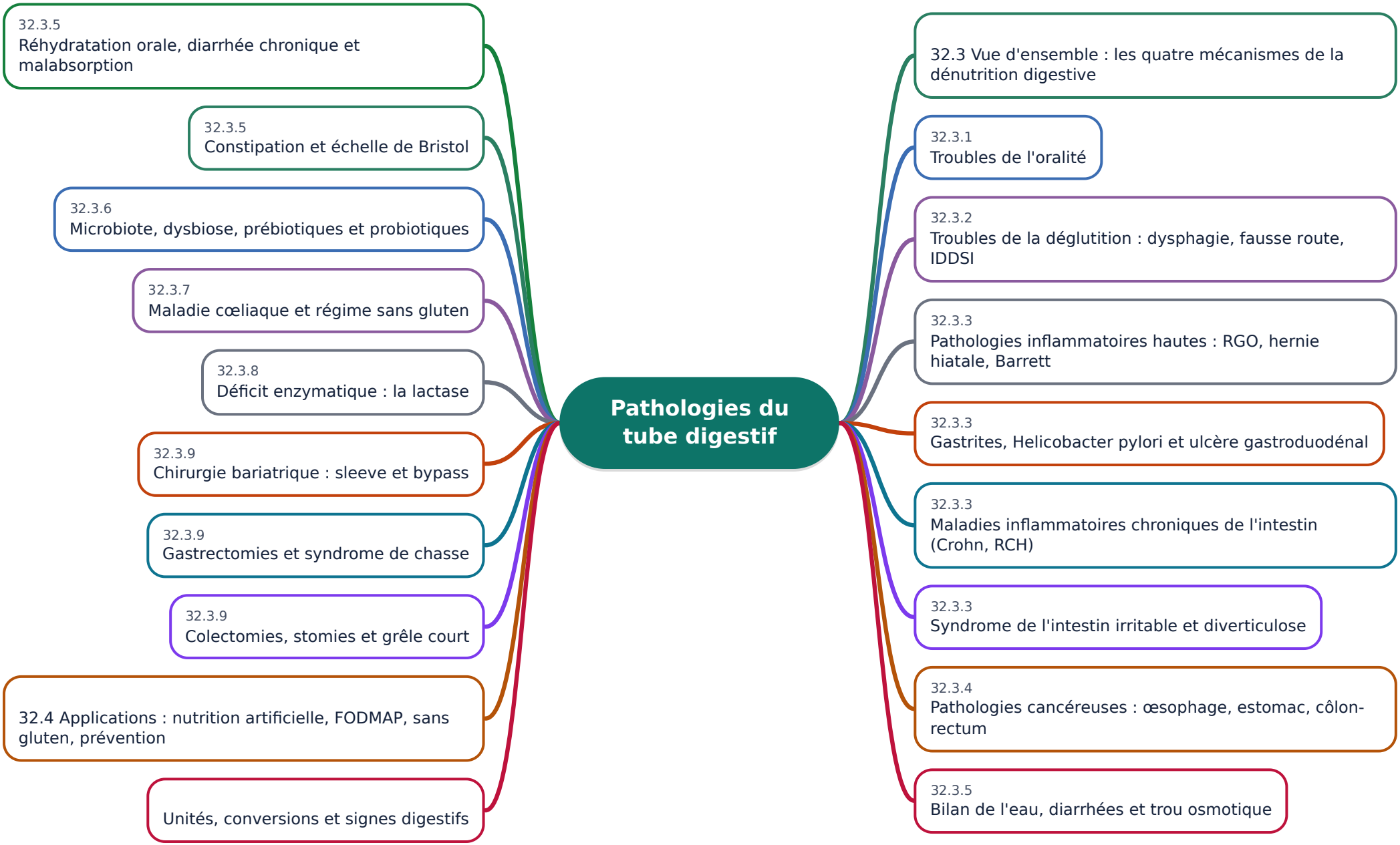
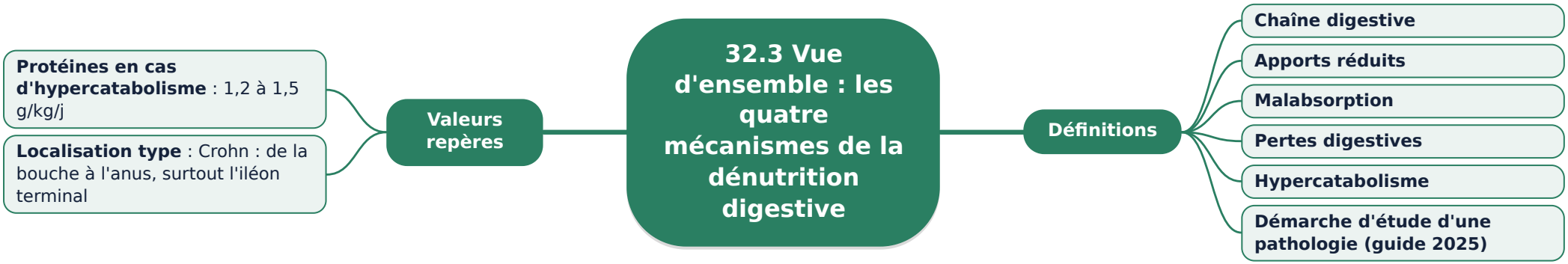
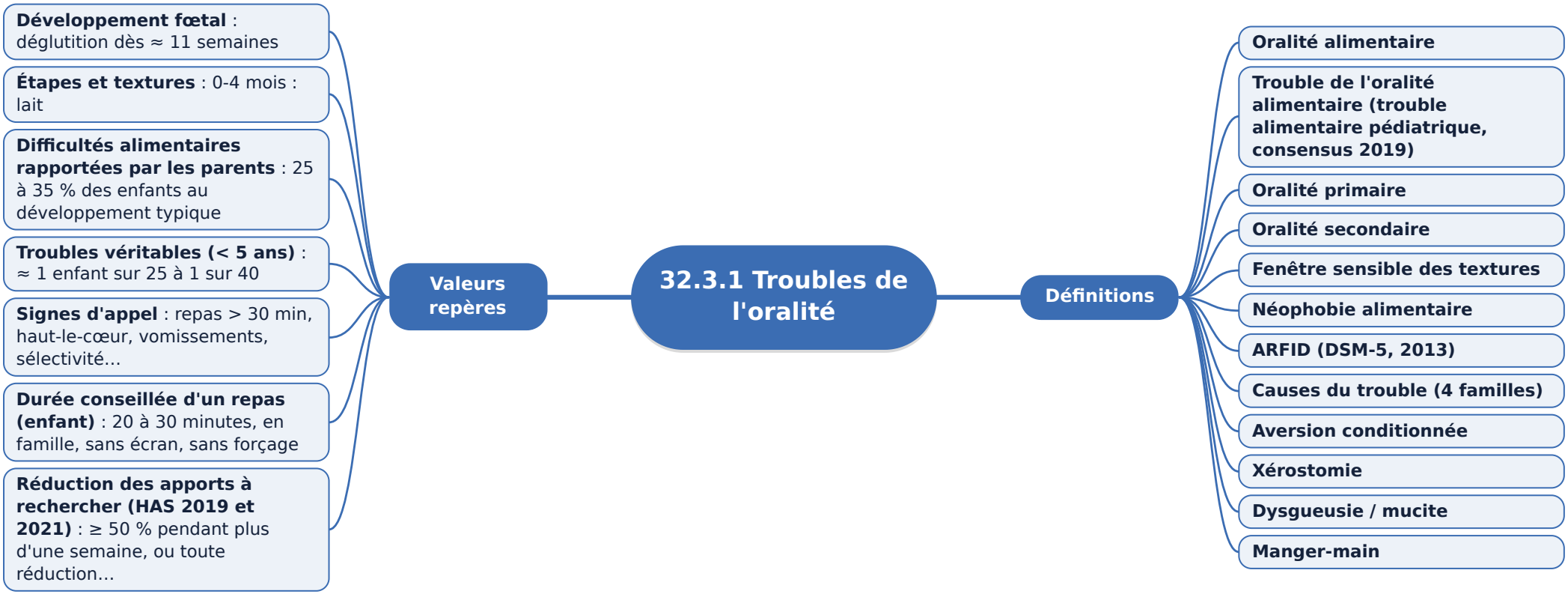

Pathologies du tube digestif
32.3 Vue d'ensemble : les quatre mécanismes de la dénutrition digestive
32.3.1 Troubles de l'oralité
32.3.2 Troubles de la déglutition : dysphagie, fausse route, IDDSI
32.3.3 Pathologies inflammatoires hautes : RGO, hernie hiatale, Barrett
32.3.3 Gastrites, Helicobacter pylori et ulcère gastroduodénal
32.3.3 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH)
32.3.3 Syndrome de l'intestin irritable et diverticulose
32.3.4 Pathologies cancéreuses : œsophage, estomac, côlon-rectum
32.3.5 Bilan de l'eau, diarrhées et trou osmotique
Unités, conversions et signes digestifs
32.4 Applications : nutrition artificielle, FODMAP, sans gluten, prévention
32.3.9 Colectomies, stomies et grêle court
32.3.9 Gastrectomies et syndrome de chasse
32.3.9 Chirurgie bariatrique : sleeve et bypass
32.3.8 Déficit enzymatique : la lactase
32.3.7 Maladie cœliaque et régime sans gluten
32.3.6 Microbiote, dysbiose, prébiotiques et probiotiques
32.3.5 Constipation et échelle de Bristol
32.3.5 Réhydratation orale, diarrhée chronique et malabsorption


32.3 Vue d'ensemble : les quatre mécanismes de la dénutrition digestive
Définitions
Chaîne digestive
Apports réduits
Malabsorption
Pertes digestives
Hypercatabolisme
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)
Valeurs repères
Protéines en cas d'hypercatabolisme : 1,2 à 1,5 g/kg/j
Localisation type : Crohn : de la bouche à l'anus, surtout l'iléon terminal


32.3.1 Troubles de l'oralité
Définitions
Oralité alimentaire
Trouble de l'oralité alimentaire (trouble alimentaire pédiatrique, consensus 2019)
Oralité primaire
Oralité secondaire
Fenêtre sensible des textures
Néophobie alimentaire
ARFID (DSM-5, 2013)
Causes du trouble (4 familles)
Aversion conditionnée
Xérostomie
Dysgueusie / mucite
Manger-main
Valeurs repères
Développement fœtal : déglutition dès ≈ 11 semaines
Étapes et textures : 0-4 mois : lait
Difficultés alimentaires rapportées par les parents : 25 à 35 % des enfants au développement typique
Troubles véritables (< 5 ans) : ≈ 1 enfant sur 25 à 1 sur 40
Signes d'appel : repas > 30 min, haut-le-cœur, vomissements, sélectivité...
Durée conseillée d'un repas (enfant) : 20 à 30 minutes, en famille, sans écran, sans forçage
Réduction des apports à rechercher (HAS 2019 et 2021) : ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction...

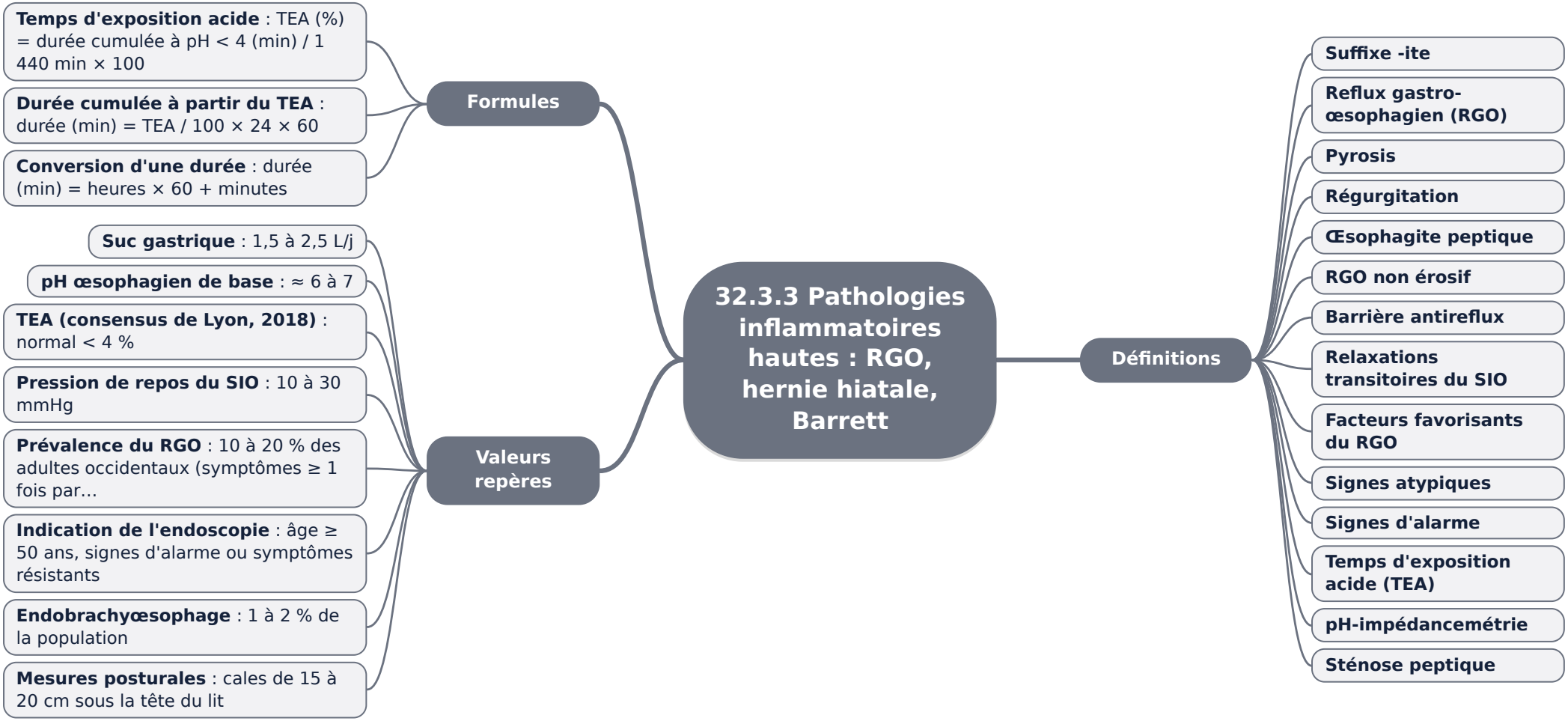
32.3.2 Troubles de la déglutition : dysphagie, fausse route, IDDSI

Définitions

- **Déglutition (3 temps)**
- **Dysphagie**
- **Dysphagie oropharyngée**
- **Dysphagie œsophagienne**
- **Odynophagie**
- **Presbyphagie**
- **Fausse route**
- **Inhalation silencieuse**
- **Achalasie**
- **Tests de dépistage**
- **IDDSI**
- **Niveaux IDDSI**
- **Épaississants**
- **Aliments à risque (toute texture)**

Valeurs repères

- **Nombre de déglutitions** : ≈ 600 par jour
- **Prévalence de la dysphagie** : ≈ 15 % des personnes âgées à domicile
- **Test de la seringue IDDSI (10 mL, 10 s)** : reste < 1 mL : niveau 0
- **Taille des particules IDDSI** : niveau 5 : ≤ 4 mm (adulte), 2 mm (enfant)
- **Tests des aliments** : fourchette (égouttage
- **Posture** : assis à 90°, tête légèrement fléchie (menton vers le...
- **Hydratation du patient dysphagique** : au moins 1,5 L de liquides épaissis ou d'eau gélifiée par...


32.3.3 Pathologies inflammatoires hautes : RGO, hernie hiatale, Barrett
Définitions
Suffixe -ite
Reflux gastro-œsophagien (RGO)
Pyrosis
Régurgitation
Œsophagite peptique
RGO non érosif
Barrière antireflux
Relaxations transitoires du SIO
Facteurs favorisants du RGO
Signes atypiques
Signes d'alarme
Temps d'exposition acide (TEA)
pH-impédancemétrie
Sténose peptique
Formules
Temps d'exposition acide : TEA (%) = durée cumulée à pH < 4 (min) / 1 440 min × 100
Durée cumulée à partir du TEA : durée (min) = TEA / 100 × 24 × 60
Conversion d'une durée : durée (min) = heures × 60 + minutes
Valeurs repères
Suc gastrique : 1,5 à 2,5 L/j
pH œsophagien de base : ≈ 6 à 7
TEA (consensus de Lyon, 2018) : normal < 4 %
Pression de repos du SIO : 10 à 30 mmHg
Prévalence du RGO : 10 à 20 % des adultes occidentaux (symptômes ≥ 1 fois par…
Indication de l'endoscopie : âge ≥ 50 ans, signes d'alarme ou symptômes résistants
Endobrachyœsophage : 1 à 2 % de la population
Mesures posturales : cales de 15 à 20 cm sous la tête du lit

32.3.3 Gastrites, Helicobacter pylori et ulcère gastroduodénal

Définitions

- **Gastrite**
- **Gastropathie**
- **Gastrite aiguë (érosive)**
- **Gastrite atrophique**
- **Gastrite à H. pylori**
- **Gastrite auto-immune**
- **Helicobacter pylori**
- **Uréase**
- **Test respiratoire à l'urée ^{13}C**
- **Cascade de Correa**
- **Ulcère gastroduodénal**
- **Érosion**
- **Agression / défense**
- **Action des AINS**

Valeurs repères

- **Prévalence de H. pylori** : ≈ la moitié de l'humanité
- **Devenir des sujets infectés** : gastrite chronique 100 %
- **Éradication** : IPP + antibiotiques, quadrithérapie de 10 à 14 jours, guidée...
- **Contrôle de l'éradication** : test respiratoire ou antigène fécal ≥ 4 semaines après les...
- **Risque d'ulcère au cours de la vie** : 5 à 10 % au XXe siècle, en baisse
- **Hémorragie ulcéreuse** : ≈ 15 à 20 % des ulcères
- **Durée des IPP** : ulcère duodénal 4 semaines
- **Anémie (OMS)** : Hb < 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme
- **Anémie d'une hémorragie** : aiguë : normocytaire, régénérative après 3 à 5 jours

32.3.3 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH)

Définitions

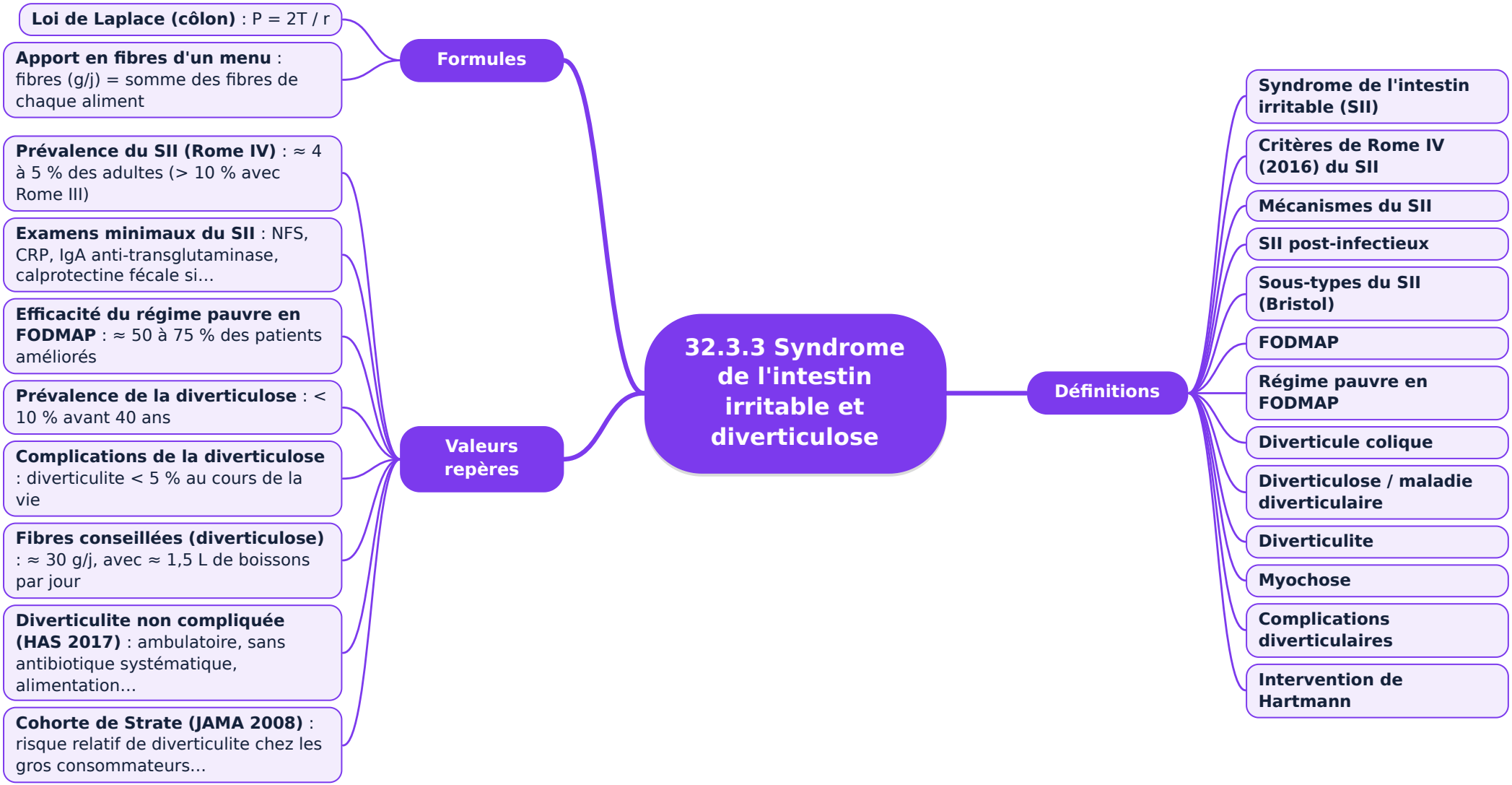
- **MICI**
- **Maladie de Crohn**
- **Rectocolite hémorragique (RCH)**
- **Transmural**
- **Fistule**
- **Ténesme (épreintes) / faux besoins**
- **Quatre facteurs des MICI**
- **Réponse immunitaire des MICI**
- **Manifestations extradigestives**
- **Calprotectine fécale**
- **Scores d'activité**
- **Critères de Truelove et Witts (colite aiguë grave)**
- **Syndrome de Koenig**
- **Colectasie**

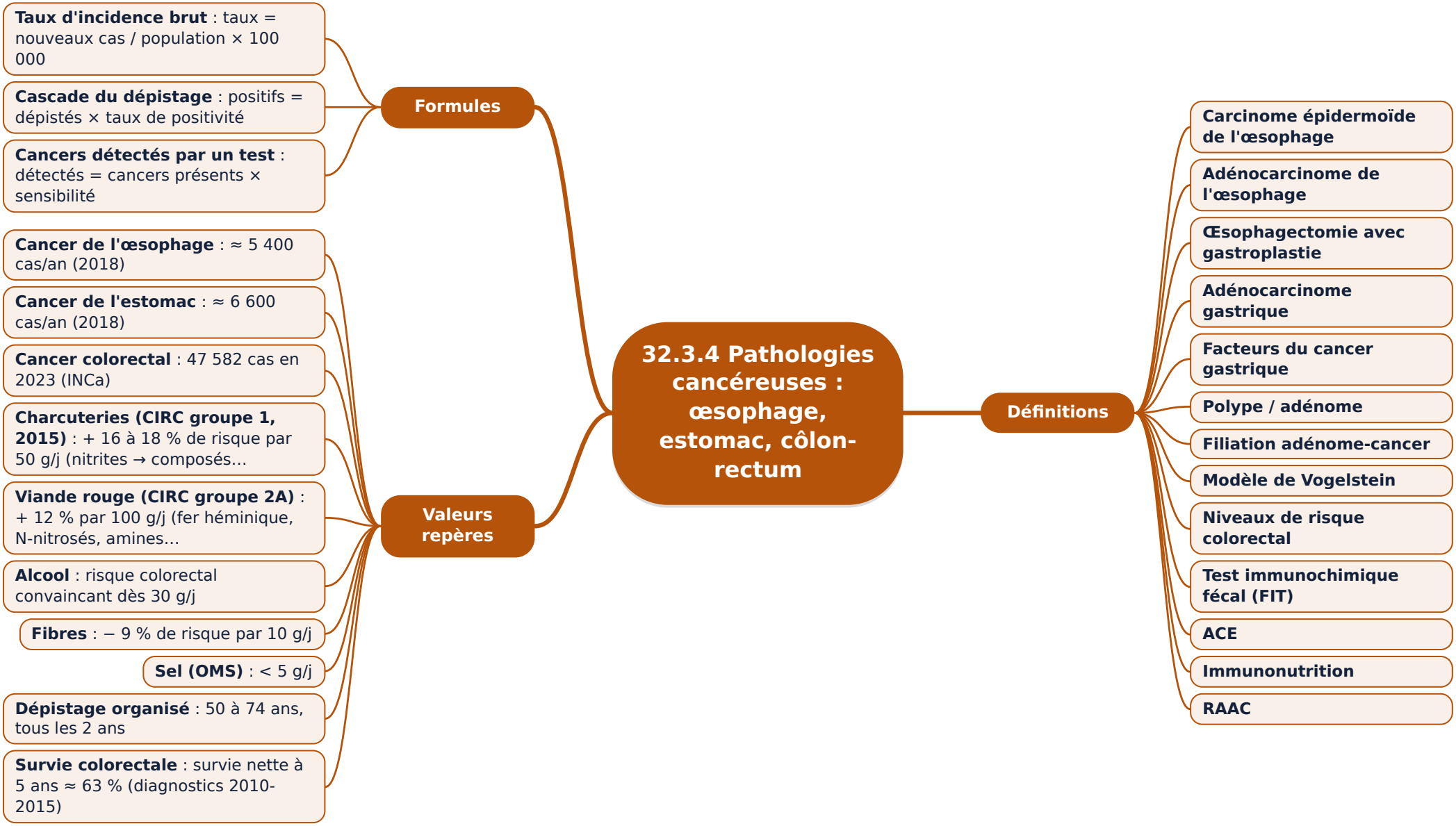
Valeurs repères

- **Prévalence en France** : > 250 000 personnes (≈ 1 sur 250)
- **Âge de début** : 15 à 35 ans surtout
- **Calprotectine fécale** : < 50 µg/g : MICI active très improbable
- **Dénutrition dans les MICI** : 20 à 85 % des patients (Crohn > RCH)
- **Protéines (ESPEN 2023)** : poussée : 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Énergie** : ≈ 25 à 30 kcal/kg/j
- **Nutrition entérale exclusive (enfant)** : 6 à 8 semaines, ≈ 120 % des besoins estimés
- **Calcium** : ≈ 1 g/j avec vitamine D (prévention de l'ostéoporose)
- **Risque de cancer colorectal** : colite étendue de plus de 8 à 10 ans, cholangite sclérosante...

Formules

- **Perte de poids** : perte (%) = (poids antérieur − poids actuel) / poids antérieur × 100
- **Indice de masse corporelle** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Besoins protéiques en poussée** : protéines (g/j) = 1,2 à 1,5 g/kg/j × poids
- **Besoins énergétiques** : énergie (kcal/j) ≈ 25 à 30 kcal/kg/j × poids


32.3.3 Syndrome de l'intestin irritable et diverticulose
Définitions
Syndrome de l'intestin irritable (SII)
Critères de Rome IV (2016) du SII
Mécanismes du SII
SII post-infectieux
Sous-types du SII (Bristol)
FODMAP
Régime pauvre en FODMAP
Diverticule colique
Diverticulose / maladie diverticulaire
Diverticulite
Myochose
Complications diverticulaires
Intervention de Hartmann
Valeurs repères
Prévalence du SII (Rome IV) : ≈ 4 à 5 % des adultes (> 10 % avec Rome III)
Examens minimaux du SII : NFS, CRP, IgA anti-transglutaminase, calprotectine fécale si...
Efficacité du régime pauvre en FODMAP : ≈ 50 à 75 % des patients améliorés
Prévalence de la diverticulose : < 10 % avant 40 ans
Complications de la diverticulose : diverticulite < 5 % au cours de la vie
Fibres conseillées (diverticulose) : ≈ 30 g/j, avec ≈ 1,5 L de boissons par jour
Diverticulite non compliquée (HAS 2017) : ambulatoire, sans antibiotique systématique, alimentation...
Cohorte de Strate (JAMA 2008) : risque relatif de diverticulite chez les gros consommateurs...
Formules
Loi de Laplace (côlon) : P = 2T / r
Apport en fibres d'un menu : fibres (g/j) = somme des fibres de chaque aliment


32.3.4 Pathologies cancéreuses : œsophage, estomac, côlon-rectum
Définitions
Carcinome épidermoïde de l'œsophage
Adénocarcinome de l'œsophage
Œsophagectomie avec gastroplastie
Adénocarcinome gastrique
Facteurs du cancer gastrique
Polype / adénome
Filiation adénome-cancer
Modèle de Vogelstein
Niveaux de risque colorectal
Test immunochimique fécal (FIT)
ACE
Immunonutrition
RAAC
Formules
Taux d'incidence brut : taux = nouveaux cas / population × 100 000
Cascade du dépistage : positifs = dépistés × taux de positivité
Cancers détectés par un test : détectés = cancers présents × sensibilité
Valeurs repères
Cancer de l'œsophage : ≈ 5 400 cas/an (2018)
Cancer de l'estomac : ≈ 6 600 cas/an (2018)
Cancer colorectal : 47 582 cas en 2023 (INCa)
Charcuteries (CIRC groupe 1, 2015) : + 16 à 18 % de risque par 50 g/j (nitrites → composés...
Viande rouge (CIRC groupe 2A) : + 12 % par 100 g/j (fer héminique, N-nitrosés, amines...
Alcool : risque colorectal convaincant dès 30 g/j
Fibres : − 9 % de risque par 10 g/j
Sel (OMS) : < 5 g/j
Dépistage organisé : 50 à 74 ans, tous les 2 ans
Survie colorectale : survie nette à 5 ans ≈ 63 % (diagnostics 2010-2015)

32.3.5 Bilan de l'eau, diarrhées et trou osmotique

Définitions

- **Diarrhée (OMS)**
- **Diarrhée osmotique**
- **Diarrhée sécrétoire**
- **Diarrhée motrice**
- **Diarrhée lésionnelle (exsudative)**
- **Diarrhée de malabsorption**
- **Stéatorrhée**
- **Trou osmotique fécal**
- **Mécanismes de l'absorption de l'eau**
- **Diarrhée toxinique**
- **Diarrhée invasive (syndrome dysentérique)**
- **Diarrhée virale**
- **TIAC**
- **Conséquences des diarrhées**

Formules

- **Trou osmotique fécal** : trou = 290 − 2 × (Na^+ + K^+) fécaux
- **Exemple osmotique** : 290 − 2 × (30 + 40) = 290 − 140 = 150
- **Exemple sécrétoire** : 290 − 2 × (100 + 30) = 290 − 260 = 30
- **Exemple intermédiaire** : 290 − 2 × (60 + 30) = 290 − 180 = 110
- **Bilan de l'eau digestive** : eau des selles = (apports + sécrétions) − (absorption grêle + absorption...

Valeurs repères

- **Liquides arrivant dans l'intestin** : ≈ 9 L/j : 1,5 à 2 L d'apports + ≈ 7 L de sécrétions (salive...
- **Réabsorption** : grêle ≈ 7 à 7,5 L/j
- **Selles normales** : 100 à 200 g/j contenant 100 à 200 mL d'eau
- **Trou osmotique** : > 125 mOsm/kg : osmotique
- **Mortalité mondiale** : ≈ 450 000 enfants de moins de 5 ans par an (OMS), par...
- **Incubations** : S. aureus 1 à 6 h
- **Températures de sécurité** : maintien au chaud > 63 °C
- **Campylobacter jejuni** : 1re cause bactérienne de diarrhée en France

32.3.5 Réhydratation orale, diarrhée chronique et malabsorption

Définitions

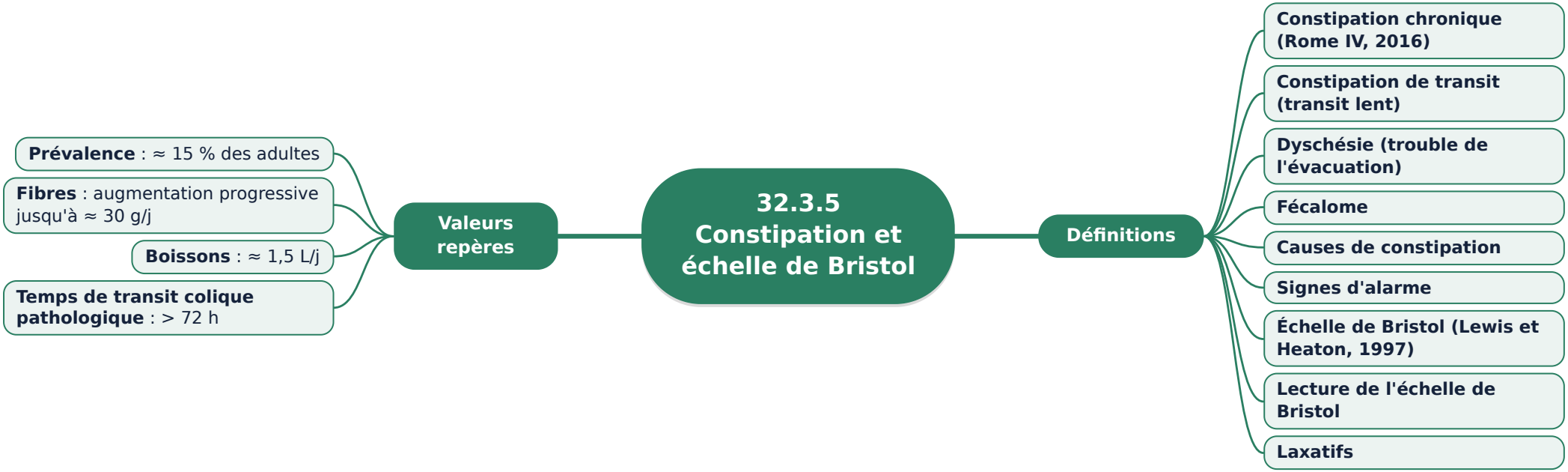
- **Principe de la réhydratation orale**
- **Soluté de réhydratation orale (SRO)**
- **Déshydratation du nourrisson**
- **Diarrhée chronique : causes fréquentes**
- **Maldigestion**
- **Malabsorption muqueuse**
- **Malabsorption**
- **Lithiase oxalique de malabsorption**

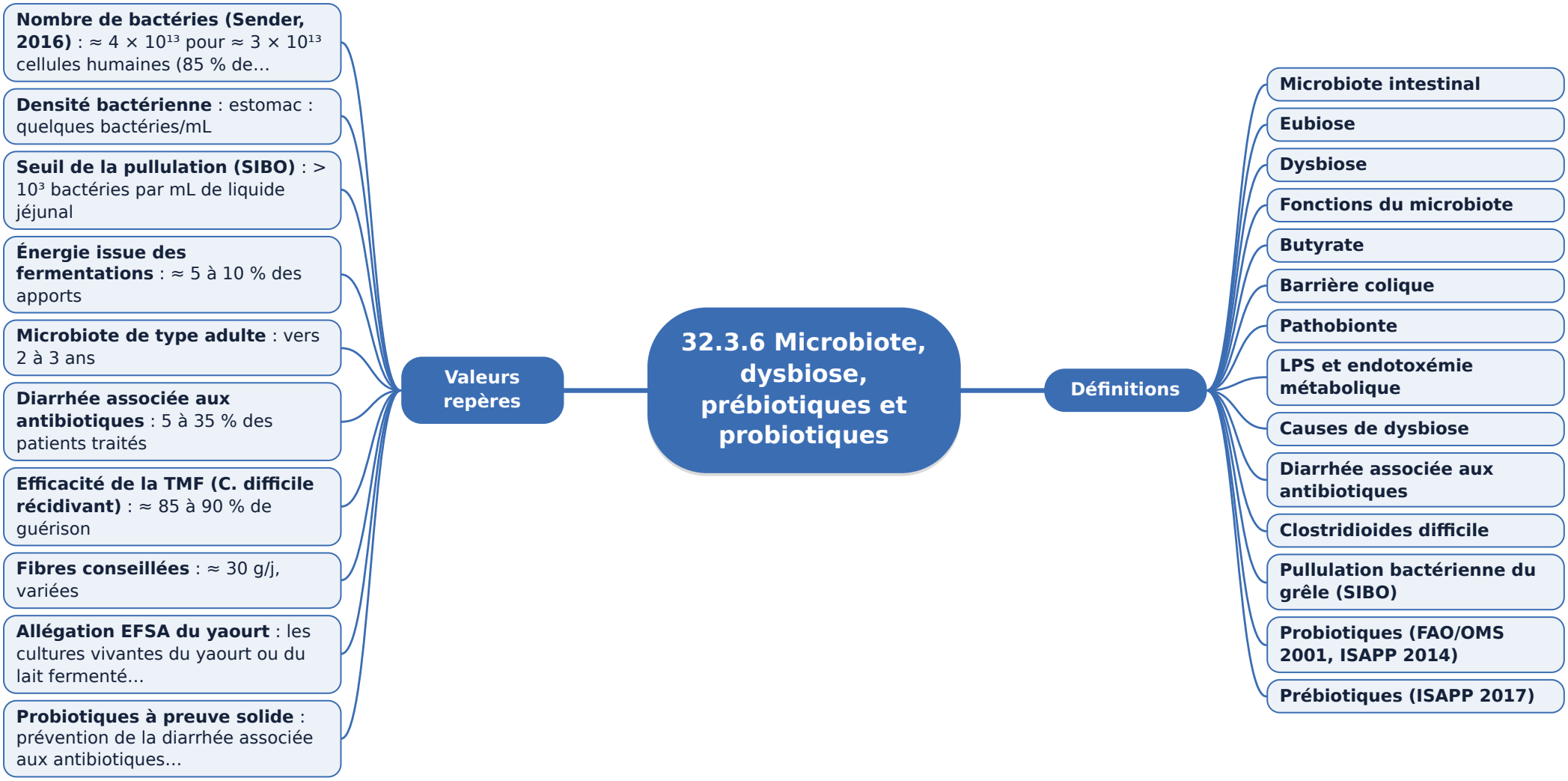
Formules

- **Perte de poids et déshydratation** : déshydratation (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Volume de réhydratation** : volume (mL) ≈ perte de poids aiguë (g)
- **Pertes en cours (nourrisson)** : ≈ 10 mL/kg par selle liquide
- **Énergie perdue par stéatorrhée** : énergie (kcal/j) = graisses fécales (g/j) × 9
- **Volume de SRO (4 premières heures)** : volume (mL) = 50 à 100 mL/kg × poids de référence
- **Sodium d'un biberon de SRO** : Na^+ (mmol) = $[Na^+]$ (mmol/L) × volume (L)
- **Concentration molaire en saccharose** : C (mol/L) = concentration massique (g/L) / M (g/mol)
- **Pertes de potassium** : K^+ perdu (mmol/j) = volume de selles (L/j) × $[K^+]$ (mmol/L)

Valeurs repères

- **SRO OMS 2002** : Na^+ 75 mmol/L
- **SRO ESPGHAN** : Na^+ 60 mmol/L
- **Boissons inadaptées seules** : eau : Na^+ ≈ 0 à 5 mmol/L
- **Réalimentation** : dans les 4 à 6 heures, sans diète prolongée
- **Prises chez le nourrisson qui vomit** : 5 à 10 mL toutes les 1 à 2 minutes
- **Stéatorrhée** : > 6 g de graisses fécales par jour
- **Vaccination contre le rotavirus (HAS 2022)** : recommandée pour tous les nourrissons, dès 6 semaines, non…
- **Réhydratation orale (nourrisson)** : 50 à 100 mL/kg en 4 h, puis ≈ 10 mL/kg par selle liquide
- **Osmolarité plasmatique** : ≈ 290 mOsm/L


32.3.5
Constipation et échelle de Bristol
Définitions
Constipation chronique (Rome IV, 2016)
Constipation de transit (transit lent)
Dyschésie (trouble de l'évacuation)
Fécalome
Causes de constipation
Signes d'alarme
Échelle de Bristol (Lewis et Heaton, 1997)
Lecture de l'échelle de Bristol
Laxatifs
Valeurs repères
Prévalence : ≈ 15 % des adultes
Fibres : augmentation progressive jusqu'à ≈ 30 g/j
Boissons : ≈ 1,5 L/j
Temps de transit colique pathologique : > 72 h


32.3.6 Microbiote, dysbiose, prébiotiques et probiotiques
Valeurs repères
Nombre de bactéries (Sender, 2016) : ≈ 4 × 10¹³ pour ≈ 3 × 10¹³ cellules humaines (85 % de...
Densité bactérienne : estomac : quelques bactéries/mL
Seuil de la pullulation (SIBO) : > 10³ bactéries par mL de liquide jéjunal
Énergie issue des fermentations : ≈ 5 à 10 % des apports
Microbiote de type adulte : vers 2 à 3 ans
Diarrhée associée aux antibiotiques : 5 à 35 % des patients traités
Efficacité de la TMF (C. difficile récidivant) : ≈ 85 à 90 % de guérison
Fibres conseillées : ≈ 30 g/j, variées
Allégation EFSA du yaourt : les cultures vivantes du yaourt ou du lait fermenté...
Probiotiques à preuve solide : prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques...
Définitions
Microbiote intestinal
Eubiose
Dysbiose
Fonctions du microbiote
Butyrate
Barrière colique
Pathobionte
LPS et endotoxémie métabolique
Causes de dysbiose
Diarrhée associée aux antibiotiques
Clostridioides difficile
Pullulation bactérienne du grêle (SIBO)
Probiotiques (FAO/OMS 2001, ISAPP 2014)
Prébiotiques (ISAPP 2017)

32.3.7 Maladie cœliaque et régime sans gluten

Définitions

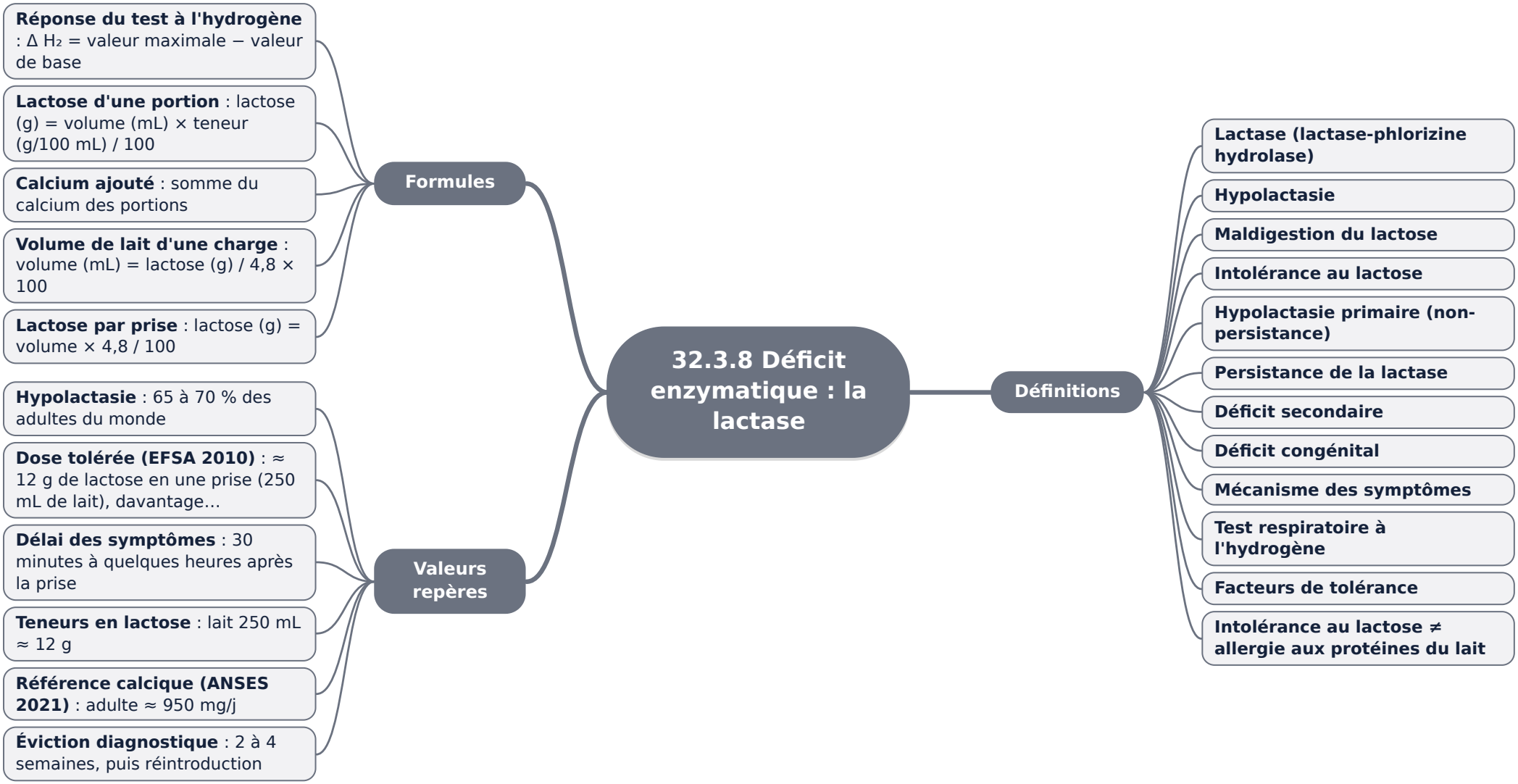
- **Maladie cœliaque**
- **Gluten**
- **Transglutaminase 2 (tissulaire, tTG)**
- **Immunité adaptative**
- **Immunité innée**
- **Atrophie villositaire**
- **Classification de Marsh**
- **Formes cliniques**
- **Diagnostic**
- **Diagnostic sans biopsie (ESPGHAN 2020, enfant)**
- **Maladie cœliaque réfractaire**
- **Céréales interdites**
- **Céréales autorisées**
- **Sensibilité au gluten non cœliaque**

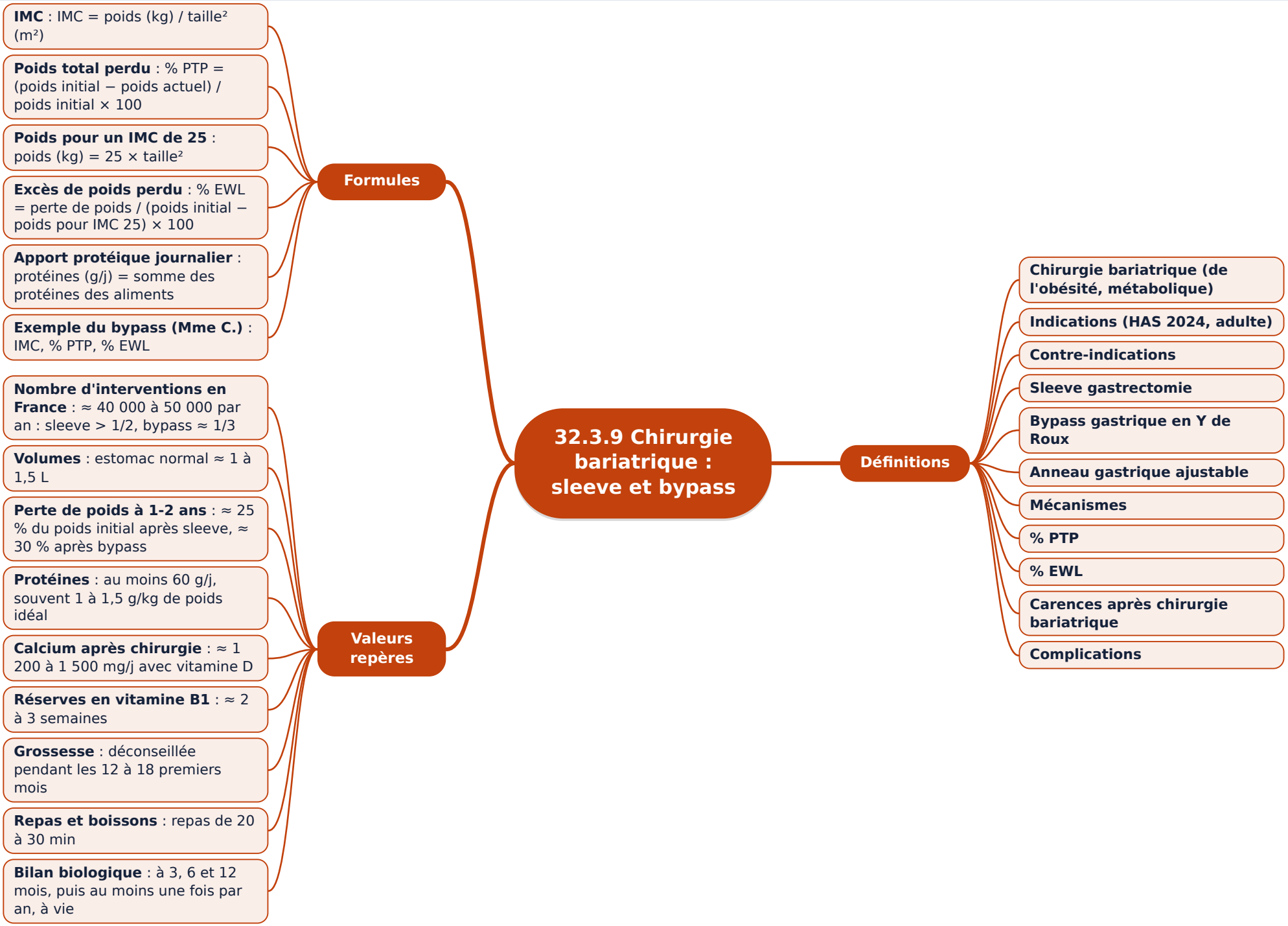
Valeurs repères

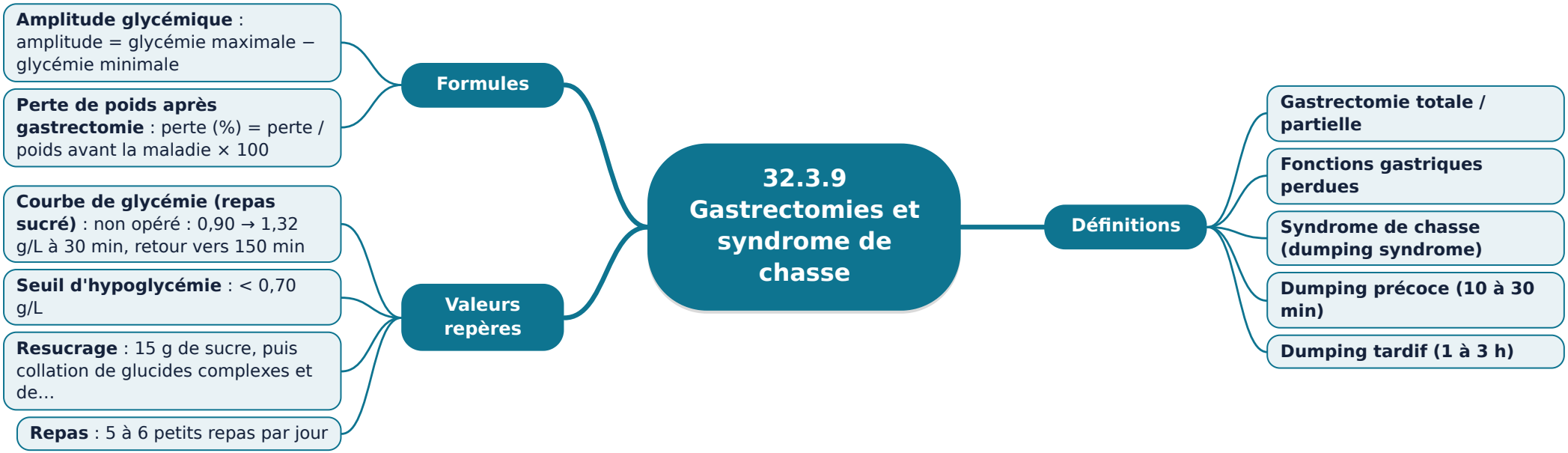
- **Prévalence** : ≈ 1 % en Europe
- **Groupes à risque** : apparentés au 1er degré ≈ 10 %
- **HLA** : ≈ 90 % des malades DQ2, presque tous les autres DQ8
- **Déficit en IgA** : 2 à 3 % des cœliaques
- **Rapport villosité / crypte normal** : ≈ 3 à 5
- **Gain de surface par villosités et microvillosités** : ≈ 30 à 60 fois un tube lisse
- **Seuils de gluten** : ≈ 50 mg/j entretient les lésions
- **Mentions (règlement (UE) n° 828/2014)** : « sans gluten » : ≤ 20 mg/kg (20 ppm)
- **Allergènes (règlement (UE) n° 1169/2011)** : 14 allergènes à déclaration obligatoire, dont les céréales...
- **Sous régime sans gluten** : symptômes : quelques semaines

Formules

- **Gluten ingéré** : gluten (mg/j) = teneur (mg/kg) × masse consommée (kg)
- **Gluten d'une fraction de tranche** : gluten = gluten de la tranche / fraction
- **Gluten d'une part de gâteau** : farine (g) = farine totale × part / masse du gâteau


32.3.8 Déficit enzymatique : la lactase
Définitions
Lactase (lactase-phlorizine hydrolase)
Hypolactasie
Maldigestion du lactose
Intolérance au lactose
Hypolactasie primaire (non-persistance)
Persistance de la lactase
Déficit secondaire
Déficit congénital
Mécanisme des symptômes
Test respiratoire à l'hydrogène
Facteurs de tolérance
Intolérance au lactose ≠ allergie aux protéines du lait
Formules
Réponse du test à l'hydrogène : Δ H₂ = valeur maximale − valeur de base
Lactose d'une portion : lactose (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100
Calcium ajouté : somme du calcium des portions
Volume de lait d'une charge : volume (mL) = lactose (g) / 4,8 × 100
Lactose par prise : lactose (g) = volume × 4,8 / 100
Valeurs repères
Hypolactasie : 65 à 70 % des adultes du monde
Dose tolérée (EFSA 2010) : ≈ 12 g de lactose en une prise (250 mL de lait), davantage…
Délai des symptômes : 30 minutes à quelques heures après la prise
Teneurs en lactose : lait 250 mL ≈ 12 g
Référence calcique (ANSES 2021) : adulte ≈ 950 mg/j
Éviction diagnostique : 2 à 4 semaines, puis réintroduction


32.3.9 Chirurgie bariatrique : sleeve et bypass
Définitions
Chirurgie bariatrique (de l'obésité, métabolique)
Indications (HAS 2024, adulte)
Contre-indications
Sleeve gastrectomie
Bypass gastrique en Y de Roux
Anneau gastrique ajustable
Mécanismes
% PTP
% EWL
Carences après chirurgie bariatrique
Complications
Formules
IMC : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
Poids total perdu : % PTP = (poids initial − poids actuel) / poids initial × 100
Poids pour un IMC de 25 : poids (kg) = 25 × taille²
Excès de poids perdu : % EWL = perte de poids / (poids initial − poids pour IMC 25) × 100
Apport protéique journalier : protéines (g/j) = somme des protéines des aliments
Exemple du bypass (Mme C.) : IMC, % PTP, % EWL
Valeurs repères
Nombre d'interventions en France : ≈ 40 000 à 50 000 par an : sleeve > 1/2, bypass ≈ 1/3
Volumes : estomac normal ≈ 1 à 1,5 L
Perte de poids à 1-2 ans : ≈ 25 % du poids initial après sleeve, ≈ 30 % après bypass
Protéines : au moins 60 g/j, souvent 1 à 1,5 g/kg de poids idéal
Calcium après chirurgie : ≈ 1 200 à 1 500 mg/j avec vitamine D
Réserves en vitamine B1 : ≈ 2 à 3 semaines
Grossesse : déconseillée pendant les 12 à 18 premiers mois
Repas et boissons : repas de 20 à 30 min
Bilan biologique : à 3, 6 et 12 mois, puis au moins une fois par an, à vie


32.3.9 Gastrectomies et syndrome de chasse
Définitions
Gastrectomie totale / partielle
Fonctions gastriques perdues
Syndrome de chasse (dumping syndrome)
Dumping précoce (10 à 30 min)
Dumping tardif (1 à 3 h)
Valeurs repères
Courbe de glycémie (repas sucré) : non opéré : 0,90 → 1,32 g/L à 30 min, retour vers 150 min
Seuil d'hypoglycémie : < 0,70 g/L
Resucrage : 15 g de sucre, puis collation de glucides complexes et de...
Repas : 5 à 6 petits repas par jour
Formules
Amplitude glycémique : amplitude = glycémie maximale − glycémie minimale
Perte de poids après gastrectomie : perte (%) = perte / poids avant la maladie × 100

32.3.9 Colectomies, stomies et grêle court

Définitions

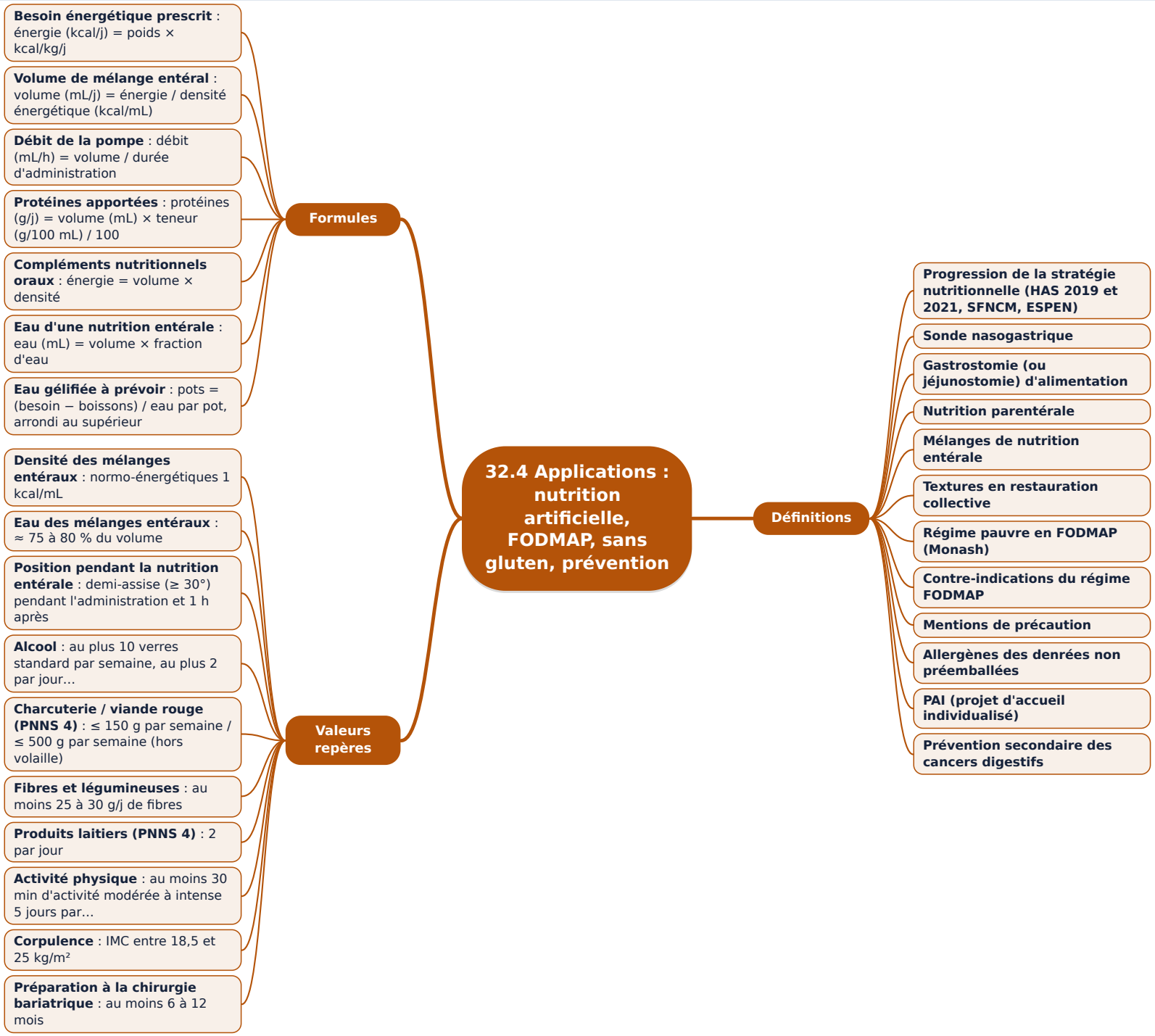
- **Colectomie / proctectomie / coloproctectomie**
- **Stomie digestive**
- **Iléostomie**
- **Colostomie gauche (Hartmann)**
- **Anastomose iléo-anale avec réservoir en J**
- **Syndrome du grêle court**
- **Insuffisance intestinale (ESPEN 2015)**
- **Classification de Messing**
- **Trois phases du grêle court**
- **Pertes sodées de la jéjunostomie**
- **Soluté hypersodé**
- **Risques du grêle court**
- **Frein iléal**

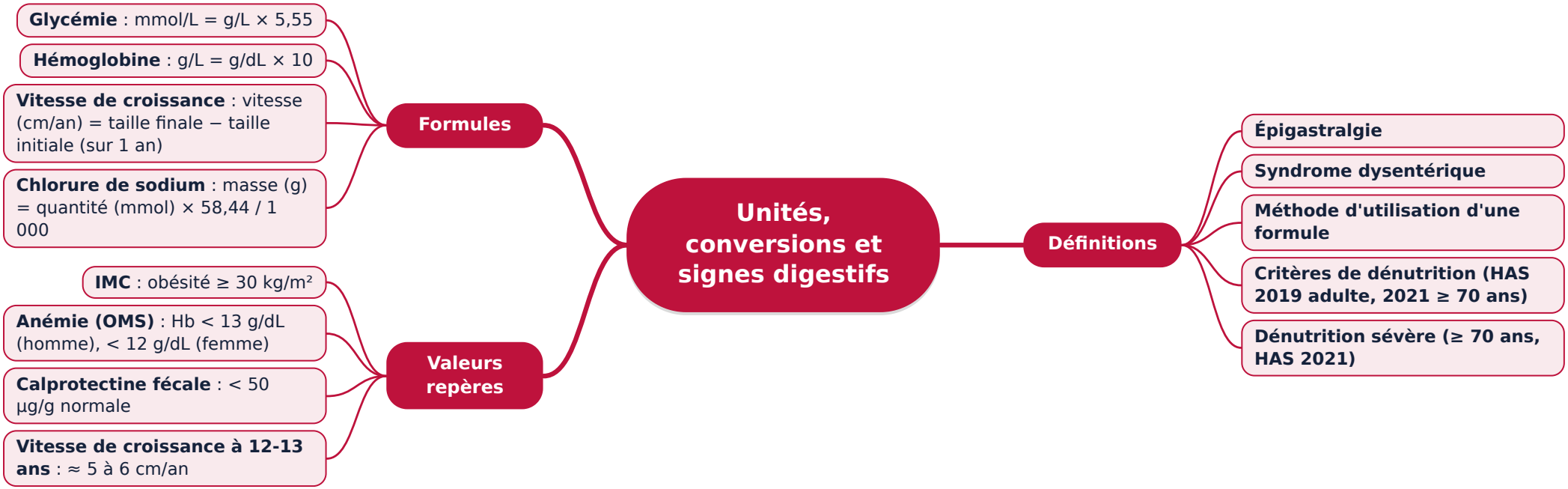
Formules

- **Perte sodée par une stomie** : Na^+ perdu (mmol/j) = débit (L/j) × [Na^+] de l'effluent (mmol/L)
- **Équivalent en chlorure de sodium** : NaCl (g) = Na^+ (mmol) × 58,44 / 1 000
- **Soluté hypersodé à préparer** : NaCl (g/L) = [Na^+] visée (mmol/L) × 58,44 / 1 000
- **Surveillance de l'hydratation** : objectifs : diurèse ≥ 1 L/j et natriurèse > 20 mmol/24 h

Valeurs repères

- **Débit d'iléostomie** : 0,5 à 1,2 L/j après adaptation
- **Seuils de NP au long cours (Messing, 1999)** : jéjunostomie : < 100 cm
- **Grêle court** : < 200 cm de grêle restant
- **Concentration en sodium des boissons** : eau, thé, café ≈ 0 à 5 mmol/L
- **Boissons hypotoniques (jéjunostomie)** : limitées à ≈ 0,5 à 1 L/j
- **Hyperphagie compensatrice** : 1,5 à 2 fois les besoins
- **Kaliémie normale** : 3,5 à 5,0 mmol/L
- **B12 injectable** : si l'iléon terminal est réséqué sur plus de 60 cm
- **Boissons (iléostomie)** : 1,5 à 2 L/j et plats salés


32.4 Applications : nutrition artificielle, FODMAP, sans gluten, prévention
Formules
Besoin énergétique prescrit : énergie (kcal/j) = poids × kcal/kg/j
Volume de mélange entéral : volume (mL/j) = énergie / densité énergétique (kcal/mL)
Débit de la pompe : débit (mL/h) = volume / durée d'administration
Protéines apportées : protéines (g/j) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100
Compléments nutritionnels oraux : énergie = volume × densité
Eau d'une nutrition entérale : eau (mL) = volume × fraction d'eau
Eau gélifiée à prévoir : pots = (besoin − boissons) / eau par pot, arrondi au supérieur
Valeurs repères
Densité des mélanges entéraux : normo-énergétiques 1 kcal/mL
Eau des mélanges entéraux : ≈ 75 à 80 % du volume
Position pendant la nutrition entérale : demi-assise (≥ 30°) pendant l'administration et 1 h après
Alcool : au plus 10 verres standard par semaine, au plus 2 par jour…
Charcuterie / viande rouge (PNNS 4) : ≤ 150 g par semaine / ≤ 500 g par semaine (hors volaille)
Fibres et légumineuses : au moins 25 à 30 g/j de fibres
Produits laitiers (PNNS 4) : 2 par jour
Activité physique : au moins 30 min d'activité modérée à intense 5 jours par…
Corpulence : IMC entre 18,5 et 25 kg/m²
Préparation à la chirurgie bariatrique : au moins 6 à 12 mois
Définitions
Progression de la stratégie nutritionnelle (HAS 2019 et 2021, SFNCM, ESPEN)
Sonde nasogastrique
Gastrostomie (ou jéjunostomie) d'alimentation
Nutrition parentérale
Mélanges de nutrition entérale
Textures en restauration collective
Régime pauvre en FODMAP (Monash)
Contre-indications du régime FODMAP
Mentions de précaution
Allergènes des denrées non préemballées
PAI (projet d'accueil individualisé)
Prévention secondaire des cancers digestifs


Unités, conversions et signes digestifs
Formules
Glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
Hémoglobine : g/L = g/dL × 10
Vitesse de croissance : vitesse (cm/an) = taille finale − taille initiale (sur 1 an)
Chlorure de sodium : masse (g) = quantité (mmol) × 58,44 / 1 000
Valeurs repères
IMC : obésité ≥ 30 kg/m²
Anémie (OMS) : Hb < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme)
Calprotectine fécale : < 50 µg/g normale
Vitesse de croissance à 12-13 ans : ≈ 5 à 6 cm/an
Définitions
Épigastralgie
Syndrome dysentérique
Méthode d'utilisation d'une formule
Critères de dénutrition (HAS 2019 adulte, 2021 ≥ 70 ans)
Dénutrition sévère (≥ 70 ans, HAS 2021)


Les pièges
« Le tabac protège de la maladie de Crohn. » → faux : Il l'aggrave ; il est « protecteur » pour la RCH.
« Le régime pauvre en FODMAP est un régime définitif. » → faux : Restriction de 2 à 6 semaines puis réintroduction et personnalisation.
« Il faut supprimer les graines et les noix en cas de diverticulose. » → faux : Aucun sur-risque n'est démontré ; les fibres sont conseillées.
« Le dépistage organisé du cancer colorectal utilise la coloscopie d'emblée chez tous les 50-74 ans. » → faux : Test immunochimique fécal tous les 2 ans ; coloscopie si positif ou si risque élevé.
« Une diarrhée sécrétoire disparaît au jeûne. » → faux : C'est la diarrhée osmotique ; la sécrétoire persiste.
« Le cola est une bonne boisson de réhydratation pour un nourrisson. » → faux : Hyperosmolaire et sans sodium : il aggrave la diarrhée.
« La néophobie alimentaire d'un enfant de 3 ans est pathologique. » → faux : Elle est normale de 2 à 6 ans ; elle devient un trouble si elle est extrême et retentit sur la croissance (ARFID).
« Le mécanisme principal du RGO est une pression de repos du SIO effondrée. » → faux : Ce sont surtout les relaxations transitoires inappropriées du SIO.
« Un temps d'exposition acide de 5 % permet de conclure à un RGO pathologique. » → faux : Il est non concluant (entre 4 et 6 %) selon le consensus de Lyon.
« Une érosion franchit la musculaire muqueuse. » → faux : C'est l'ulcère qui la franchit ; l'érosion reste dans la muqueuse.
« Le lait est conseillé pour cicatriser un ulcère. » → faux : Il stimule la sécrétion acide (rebond) ; aucun régime n'est nécessaire.
« La maladie de Crohn ne touche que le côlon. » → faux : Elle peut toucher tout le tube, surtout l'iléon terminal.